

ERITEMA MULTIFORME.

Pedro Rodríguez-Jiménez, Pablo Chicharro, Alejandra Reolid

INTRODUCCIÓN

El eritema multiforme (EM) es un síndrome autolimitado agudo, de intensidad leve o moderada y que tiende a la recurrencia en al menos el 30% de pacientes. Aparece en todas las edades, siendo más frecuente en adolescentes y personas jóvenes y raro en niños y ancianos. El síndrome normalmente se relaciona con una infección aguda, siendo en más de la mitad de los casos el culpable el virus del herpes simple (VHS). La segunda causa más frecuente y la primera en casos pediátricos la infección por *M.pneumoniae*. La causa farmacológica es infrecuente y normalmente se tratan de reacciones adversas a medicamentos con una morfología “EM-like”. Por otro lado, hablaremos de:

- EM menor cuando aparecen lesiones cutáneas sin lesiones mucosas y
- EM mayor cuando estas últimas si están presentes, lo que ocurre en aproximadamente el 70% de pacientes.

DIAGNÓSTICO

El EM se define por sus características clínicas: lesiones en placa con morfología en diana con o sin ampolla central, con un eritema de color vivo o un tinte purpúrico y con un predominio de afectación en cara y región acral de extremidades que aparecen en pocos días. Los pacientes con afectación mucosa presentan erosiones en labios y mucosa oral y afectación de la mucosa ocular, nasal, uretral y anal puede ocurrir. Un tercio de pacientes presenta fiebre franca en el momento del brote de las lesiones y estos pacientes suelen asociar linfadenopatías cervicales. No hay alteraciones analíticas específicas en el EM, pudiendo encontrarse leucocitosis, elevación de reactantes de fase aguda y de transaminasas. Si existe sintomatología respiratoria, una radiografía de tórax y una PCR para *M. pneumoniae* deberían realizarse solo en el caso de dudas diagnósticas (con otros procesos ampollosos, urticaria, síndrome de Sweet o vasculitis) se realizará una biopsia que mostrará un infiltrado de linfocitos en la unión dermo-epidérmica junto con ligera necrosis de la epidermis, lo que lo suele permitir la diferenciación del espectro de lesiones del síndrome de Stevens-Johnson/Necrosis Epidérmica Tóxica donde la necrosis epidérmica es muy pronunciada.



TRATAMIENTO

Las lesiones son autolimitadas y curan sin secuelas por lo que el objetivo del tratamiento es el alivio sintomático y la reducción de la duración de la sintomatología.

- **Corticoides sistémicos.** El uso sistemático de corticoides sistémicos, pese a su controversia en cuanto a las complicaciones infecciosas, está recomendado en pacientes con lesiones de intensidad moderada o grave a dosis de 0.5-1 mg/kg en pauta corta de 5-7 días.
- **Anestésicos tópicos.** Para las lesiones orales los anestésicos y los corticoides tópicos proporcionarían alivio sintomático. En estos pacientes es fundamental evaluar si las lesiones orales impiden la alimentación per oris de cara a valorar ingreso.



Las lesiones de EM aparecen después de la infección por VHS, con una media de 7 días tras el brote, y por tanto no se recomienda el tratamiento antivírico en el momento agudo, sin embargo, la terapia supresora es efectiva para prevenir las recurrencias al disminuir los episodios de infección por VHS. En raras ocasiones el brote de VHS puede aparecer a la vez que el brote de

EM o después, pudiendo iniciarse en ese momento tratamiento antivírico tras demostrar la infección con una muestra para PCR que mostrará el resultado en 24 horas.

PUNTO ALERTA

- El diagnóstico del EM es clínico y solo ante la duda con otros procesos deben realizarse exploraciones complementarias.
- El tratamiento es sintomático, con corticoides orales a dosis de 0.5mg/kg durante 5 días, utilizándose el Aciclovir solo para la prevención de futuros brotes y no de manera general en el tratamiento agudo.

BIBLIOGRAFÍA

- Auquier-Dunant A, Mockenhaupt M, Naldi L, Correia O, Schöder W, Roujeau J. SCAR Study Group. Severe Cutaneous Adverse Reactions. Correlations between clinical patterns and causes of erythema multiforme majus, Stevens-Johnson Syndrome and toxic epidermal necrolysis: results of an international prospective study. Arch Dermatol. 2002;138(8):1019-24.
- Weston WL. Herpes-associated erythema multiforme. J Invest Dermatol. 2005;124(6):XV-XVI.
- Wetter DA, Davis MD. Recurrent erythema multiforme: Clinical characteristics, etiologic associations, and treatment in a series of 48 patients at Mayo Clinic, 2000 to 2007. J Am Acad Dermatol. 2010;62(1):45-53.